

# 分子標的治療薬:薬剤師の実践ポイント

服薬指導・相互作用・病院との連携のポイント

## 1 分子標的薬の薬薬連携 — 経口TKI・抗体薬・ADC

| 病院薬剤師                            | 病院と共有する情報              | 保険薬局薬剤師                           |
|----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| ① バイオマーカー検査の結果とレジメンの整合性を監査       | 減量段階<br>(用量レベル・錠数)     | ① 経口TKIの服用時点・残薬・自己調整の確認           |
| ② 抗体薬・ADCの投与管理(インフュージョンリアクション対策) | 家庭血圧・尿蛋白<br>(血管新生阻害薬)  | ② CYP3A4・胃酸分泌抑制薬・グレープフルーツ等の相互作用確認 |
| ③ 心エコー・画像検査など定期検査の計画             | 皮疹・下痢の程度<br>(EGFR阻害薬)  | ③ 血管新生阻害薬は家庭血圧の記録を薬局ごとに確認         |
| ④ ILD等の重篤な副作用発生時の院内連携            | 咳・息切れの有無<br>(ILDの早期発見) | ④ 皮膚障害のスキンケア指導と外用薬の使い方            |
| ⑤ 減量段階(用量レベル)と休薬基準を薬局へ伝達         |                        | ⑤ 減量後の用量・錠数を処方箋と照合(規格違いの防止)       |

## 2 経口分子標的薬の服用時点と相互作用の要点

|         |                              |                                      |
|---------|------------------------------|--------------------------------------|
| エルロチニブ  | 空腹時 空腹時(食事の1時間以上前または食後2時間以降) | ✓ 胃酸分泌抑制薬で吸収↓ ✓ 喫煙で濃度↓ ✓ CYP3A4      |
| ニロチニブ   | 空腹時 空腹時 1日2回(約12時間ごと)        | ✓ 食後の服用で吸収↑ ✓ QT延長 ✓ CYP3A4・グレープフルーツ |
| ラパチニブ   | 空腹時 空腹時(食事の1時間以上前または食後1時間以降) | ✓ 食後の服用で吸収↑ ✓ CYP3A4 ✓ 下痢            |
| イマチニブ   | 食後 食後(多めの水で)                 | ✓ CYP3A4阻害薬・グレープフルーツ ✓ 浮腫            |
| レゴラフェニブ | 食後 食後(高脂肪食の後は避ける)            | ✓ 手足症候群 ✓ 投与初期の肝機能・血圧                |
| パルボシクリブ | 指示どおり 1日1回 21日服用・7日休薬        | ✓ 好中球減少 ✓ CYP3A4阻害薬                  |
| アベマシクリブ | 指示どおり 1日2回 連日                | ✓ 開始早期の下痢 ✓ CYP3A4阻害薬                |

● 空腹時 ● 食後 ● 食事に関係なく ● 指示どおり 服用時点は交付時に具体的な時刻で説明

## 3 相互作用・併用注意(他院処方・市販薬・サプリを含む)

| 重要度                           | 薬剤(機序)                       | 相手の薬(区分)                       | 起こること         | 薬局での対応               |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------|----------------------|
| <b>禁忌</b><br>添付文書<br>併用禁忌     | ロルラチニブ<br>CYP3A4強誘導          | 処方薬<br>リファンピシン(抗結核薬)           | 重篤な肝障害・効果減弱   | 併用しない。他院の抗結核薬の処方を確認  |
| <b>注意</b><br>添付文書<br>併用注意     | イマチニブ・ニロチニブ等<br>CYP3A4阻害     | 処方薬<br>クラリスロマイシン・アゾール系抗真菌薬     | 血中濃度↑ → 副作用↑  | 他院の抗菌薬・抗真菌薬の処方を確認    |
| <b>注意</b><br>添付文書<br>併用注意     | エルロチニブ・ダサチニブ等<br>胃内pH上昇で吸収低下 | 処方薬 市販薬<br>PPI・H2ブロッカー(市販の胃薬も) | 血中濃度↓ → 効果減弱  | 市販の胃薬も確認、服用時間を調整     |
| <b>注意</b><br>添付文書<br>用法・用量    | ニロチニブ<br>食事で吸収が増加            | 生活習慣<br>食事と一緒に服用               | 血中濃度↑ → QT延長等 | 食事の1時間以上前か食後2時間以降に服用 |
| <b>注意</b><br>添付文書<br>併用注意     | 経口TKI<br>CYP3A4阻害・誘導         | サプリ・食品<br>グレープフルーツ・セイヨウオトギリソウ  | 副作用↑・効果↓      | 食品・サプリの摂取を聴取         |
| <b>確認</b><br>添付文書<br>重要な基本的注意 | 血管新生阻害薬<br>創傷治癒遅延            | 処置・検査<br>手術・抜歯の予定              | 創傷治癒遅延・出血     | 予定を病院と共有し休薬期間を確認     |

## 4 服薬指導タイムライン(声かけ例)

| ① 治療開始前                                                 | ② 開始～2週                                | ③ 1～3か月                         | ④ 長期服用中                                       |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| “この薬は毎日同じ時間に飲み続けることが大切です。食事との関係もあるので、飲むタイミングを一緒に決めましょう” | “顔や胸の発疹、下痢が出始める時期です。保湿と下痢止めを早めに使いましょう” | “息切れや空咳が続く時は、次の受診を待たずに連絡してください” | “副作用がづらい時に自己判断で減らさず、まず相談してください。量を調整する方法があります” |
| ✓ 薬局で確認<br>服用時点(空腹時・食後)、胃薬・CYP3A4関連の併用薬、サプリ             | ✓ 薬局で確認<br>電話フォローで皮疹・下痢のGrade、家庭血圧を確認  | ✓ 薬局で確認<br>咳・息切れ、血圧手帳、手足の症状     | ✓ 薬局で確認<br>残薬・自己調整の有無、肝機能・心機能検査の予定            |
| △ ここに注意<br>グレープフルーツ・セイヨウオトギリソウは避ける                      | △ ここに注意<br>水様便が1日4回以上増える時は連絡           | △ ここに注意<br>息切れ・空咳・発熱はILDを疑い至急受診 | △ ここに注意<br>自己中断・減量はトレーシングレポートで共有              |